

Среднеуретральный слинг (при стрессовом недержании)

Информация для пациента · Быстрая и эффективная операция при стрессовом недержании мочи

WARWIKI

Среднеуретральный слинг — наиболее распространённая операция при **стрессовом недержании мочи (SUI)** у женщин: непроизвольное подтекание мочи при кашле, смехе, физической нагрузке. Узкая мягкая лента устанавливается под среднюю часть уретры как поддерживающий гамак, удерживая её закрытой при повышении давления. Операция короткая, как правило амбулаторная, высокоэффективная и долговременная.

Об этой операции

Через небольшой разрез внутри влагалища тонкая лента укладывается **без натяжения** под среднюю часть уретры. При кашле или физическом усилии уретра прижимается к слингу и остаётся закрытой. **Никаких настроек** после операции не требуется — слинг работает самостоятельно. Существуют разные доступы (позадилонный и трансобтураторный), а также однопортовые «мини»-слинги; хирург выберет оптимальный вариант.

О сетчатом импланте

Синтетический среднеуретральный слинг — одна из **наиболее изученных** операций в гинекологической урологии с доказанной долгосрочной безопасностью и эффективностью. Он **принципиально отличается** от трансвагинальных сеток для коррекции пролапса, в отношении которых FDA выпустило предупреждение. Если вы предпочитаете избежать синтетического материала, альтернативой служит слинг из **собственной ткани** (аутологичный фасциальный слинг).

ТЕРМИНЫ

Стрессовое недержание

Подтекание мочи при нагрузке — кашле, смехе, подъёме тяжестей.

Среднеуретральный слинг

Сетчатая лента, поддерживающая среднюю часть уретры.

Без натяжения

Слинг лежит под уретрой, не сдавливая её.

Позадилонный / трансобтураторный

Два доступа для проведения слинга; оба эффективны.

Аутологичный слинг

Слинг из собственной ткани пациентки вместо синтетической сетки.

Экспозиция сетки

Редкое осложнение, при котором небольшой участок сетки становится виден; поддается лечению.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под анестезией (общей или спинальной), поэтому во время неё вы ничего не чувствуете; занимает обычно менее 30 минут. Большинство пациентов **уходит домой в тот же день** с умеренной болезненностью и быстро возвращается к лёгкой активности.

Как подготовиться

- Соблюдайте **инструкции по анестезии** (голодание, отмена антикоагулянтов по назначению).
- **Анализ мочи** для исключения инфекции; при необходимости — уродинамическое исследование.
- Организуйте сопровождение; планируйте щадящий режим на несколько недель.

Что происходит

- 1 Вводится анестезия; вводятся антибиотики.
- 2 Выполняется небольшой разрез во влагалище, лента укладывается без натяжения под среднюю часть уретры.
- 3 Небольшие точки выхода (над лобком или в паху) закрываются самостоятельно; влагалищный разрез ушивается.
- 4 Перед выпиской вас попросят помочиться, чтобы убедиться в нормальном опорожнении мочевого пузыря.

После операции

- Умеренная болезненность и небольшие кровянистые выделения — норма.
- **Избегайте тяжёлых нагрузок, натуживания и половой жизни около 6 недель.**
- При затруднённом мочеиспускании первое время может потребоваться кратковременная катетеризация.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Не получается помочиться** или ощущается неполное опорожнение
- Повышение температуры или обильное кровотечение
- Нарастающая боль, а также боль при половом акте или влагалищные выделения в дальнейшем (возможная проблема со слингом)

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Среднеуретральный слинг поддерживает уретру и устраняет стрессовое подтекание мочи — операция быстрая, амбулаторная, высокоэффективная; настройка после не требуется.
2. Сетка хорошо изучена и принципиально отличается от отозванных сеток для пролапса; при желании возможен аутологичный слинг.
3. Избегайте нагрузок и половой жизни ~6 недель. Обратитесь к врачу, если не можете помочиться, появилась температура или боль/выделения.